2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

PLANO DE PARTO COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS GESTANTES

Josefa Yolanda Vitório Costa - Enfermeira Residente no Programa Multiprofissional em Saúde da Família - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
Ana Aline Rodrigues Oliveira - Enfermeira Residente no Programa Multiprofissional em Saúde da Família - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
Jeorgia Costa Lima - Enfermeira e preceptora da Estratégia de Saúde da Família em Recife/PE
Shirlene Alves Alheiros - Enfermeira e preceptora da Estratégia de Saúde da Família em Recife/PE

Plano de Parto

Fonte: Acervo pessoal, 2026.

PRINCIPAIS ACHADOS

- Promover empoderamento das gestantes.
- Reforça direitos reprodutivos e assistenciais.
- Favorecer diálogo educativo entre profissional e usuária.
- Redução do medo e da ansiedade relacionados ao parto.
- Qualifica o cuidado pré-natal na APS.

Introdução

O plano de parto (PP) corresponde a um instrumento de caráter documental, realizado durante o pré-natal, no qual as mulheres afirmam suas preferências, além de conhecer seus direitos.

Objetivo

Descrever a experiência de construção e aplicação de um PP na atenção primária.

Método

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa. A atividade consistiu na elaboração de um plano de parto que visou diminuir o medo e a ansiedade das gestantes próximas ao parto, além de evidenciar os direitos das mulheres. Para elaboração, realizou-se busca na literatura em SciELO, BVS e materiais de instituições de respaldo na saúde. Após roteiro prévio do conteúdo, utilizou-se Canva para criação do layout. O plano divide-se em orientações sobre parto (sinais de início do trabalho de parto; momento durante; parto e nascimento; necessidade de cesariana) e cuidados com RN (aleitamento, coto umbilical, banho pós-parto).

Resultados

Os resultados da utilização do instrumento foram evidenciados pelos relatos das gestantes e puérperas, o medo recorrente de ficar sem acompanhante foi superado ao descobrirem leis que amparam esse direito. O plano é preenchido em conjunto com a gestante, o que permitiu esclarecer dúvidas sobre violência obstétrica e estabelecer diálogo educativo; apresenta baixo custo e preenchimento rápido.

Conclusão

A guisa da conclusão o plano demonstrou grande potencial na APS, fomentando empoderamento das gestantes, reduzindo medos/ansiedades e reforçando direitos.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
JOSEFA YOLANDA VITÓRIO COSTA
ENFERMEIRA RESIDENTE NO PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

E-mail: enferyolanda@gmail.com
Contatos: (82) 99956-7784

IMIP